HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Вступительный урок

воспалённое пищеварение

О чём этот урок

Это вступительный урок к **протоколу по воспалённому пищеварению**. По результатам диагностического теста у вас определён **воспалительный тип пищеварения**. Разбираем, что это значит, какие жалобы и диагнозы для него характерны, чем он опасен, какие обследования стоит пройти и как будет строиться работа на программе.

1. Что такое воспалительный тип пищеварения

При этом типе в состоянии **хронического воспаления** находятся:

- слизистая оболочка желудка, тонкого или толстого кишечника;
- также могут быть стенки жёлчного пузыря и паренхима поджелудочной железы.

На этом фоне меняется работа ЖКТ и микробиом: может развиться **дисбиоз**, **СИБР** (синдром избыточного бактериального роста), возможна **хеликобактерная инфекция**.

Типичные диагнозы

Диагноз	Что это
Гастрит	Воспаление слизистой желудка — различные типы
ГЭРБ	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Дуоденит	Воспаление двенадцатиперстной кишки
Холецистит	Воспаление жёлчного пузыря
Хронический панкреатит	Воспаление поджелудочной железы
Воспалительные заболевания кишечника	Колит, язвенный колит, энтерит, энтероколит и т. д.
Дисбиоз, СИБР, хеликобактерная инфекция	Нарушения микрофлоры и инфекция H. pylori

Далеко не факт, что у вас есть все эти диагнозы, — скорее, что-то выборочно.

2. Как проявляется хроническое воспаление в ЖКТ

Чтобы заподозрить воспаление, достаточно **двух-трёх пунктов** из списка. Разные типы болей указывают на разную локализацию воспаления — подробнее в следующих уроках.

Изжога, жжение, боли

✔️ изжога после шоколада, кофе, алкоголя, цитрусовых, томатов, кислых напитков — продуктов кислого, горького, жгучего вкуса

✔️ жжение в пищеводе и желудке от кислого, острого

✔️ боли или жжение в животе через 1–1,5 часа после еды

✔️ ночные боли в животе (с 1:00 до 3:00)

✔️ колющие боли в правом боку

✔️ острые, сильные боли на голодный желудок

✔️ боли на алкоголь, кислое, острое, жгучее, горькое

✔️ боли в животе и левом подреберье, опоясывающие, отдающие в спину

Другие признаки

✔️ вздутие и боли на ферментированную пищу (квашеные овощи, кисломолочное) и пробиотики — связано с СИБР

✔️ лучше после обволакивающего: овсянка, льняная каша, картофельное пюре, кокосовое молоко

✔️ эпизодическая тошнота без связи с едой

✔️ диарея или несформированный стул

✔️ слизь в стуле

Признаки других типов пищеварения — это нормально

Длительное хроническое воспаление (месяцы, годы) **истощает функции органов ЖКТ**. Поэтому со временем появляются признаки **вялого** и **чувствительного** типа:

- тяжесть после еды; ощущение, что еда долго стоит в желудке и медленно переваривается;
- вздутие после еды или вечером — во второй половине дня, после 15–16 часов;
- изжога не только на кислое, горькое, острое, но и на мучное, сладкое, крахмалистое;
- отрыжка; тошнота на жирную или белковую еду;
- чувствительность пищевода и желудка к температуре — дискомфорт при глотании очень холодного или горячего;
- газообразование от клетчатки: фрукты со шкуркой (яблоки, груши), много зелени, капустные.

> **Протокол учитывает всё это:** и воспаление, и сниженную работу органов (вялый тип), и повышенную чувствительность слизистой (чувствительный тип). Но **приоритет — работа с воспалением**.

3. Риски воспалительного типа пищеварения

Риски не иллюзорные. Главный — **обострение** уже имеющихся заболеваний: при определённых обстоятельствах хроническое воспаление может перейти в острое.

Риск	Пояснение
Язва желудка и 12-перстной кишки	—
Эрозивный гастрит → атрофический гастрит	Развитие эрозий в желудке
Панкреатит с фиброзом	Сложные структурные изменения поджелудочной железы
Мальабсорбция	Нарушение всасывания нутриентов
СРК с воспалительным компонентом	—
Синдром повышенной кишечной проницаемости	Виден по последствиям: аллергические реакции, аутоиммунные процессы

Каскад Корреа — известная схема того, как эволюционирует воспаление в желудке: хроническое воспаление → кишечная метаплазия (появление клеток кишечного типа в желудке) → онкология желудка. Это происходит в небольшом проценте случаев (менее 1 %), но шанс есть. Поэтому важно уметь уменьшать хроническое воспаление и не допускать его перехода в следующую стадию.

4. Какие обследования пройти

Это не обязательное требование для прохождения программы, но при воспалительном типе **особенно важно выяснить причину жалоб и оценить состояние ЖКТ**. Если вы ещё не обследовали ЖКТ подробно — искренняя рекомендация это сделать.

Важно: точный список анализов для вашего случая назначает **врач-гастроэнтеролог**. Ниже — наиболее информативные анализы и процедуры, чтобы вы понимали, зачем они нужны. Результаты оценивает профильный специалист индивидуально и в комплексе.

4.1. УЗИ органов брюшной полости

Базовое простое обследование (часто в рамках диспансеризации раз в 1–2 года). Оценивает **печень, жёлчный пузырь, поджелудочную железу**: структурные изменения, состояние стенок пузыря, состояние жёлчи (взвесь, камни), полипы.

УЗИ с нагрузкой — оценка сократительной способности жёлчного пузыря, если нет противопоказаний (например, камней).

4.2. ФГДС — оценка функций желудка

Оправдана при болях в желудке после еды или натощак, частой изжоге, признаках ГЭРБ. Тонкая трубка с аппаратом на конце оценивает слизистую пищевода, клапаны желудка, структуру слизистой и воспаление. Берётся **биопсия** в нескольких точках — для диагностики **H. pylori** и оценки клеток слизистой.

> **Не бойтесь:** сейчас во многих местах ФГДС проводят под седацией — психологически это гораздо проще.

4.3. Оценка воспаления в кишечнике

Кал на кальпротектин и скрытую кровь — одни из лучших анализов: в первом приближении показывают, есть ли воспаление. Плюс кальпротектина — он отражает воспаление **во всём кишечнике**, и в тонкой, и в толстой кишке. Колоноскопия показывает только толстую кишку и проводится **по показаниям**, если с анализами что-то не так.

4.4. Анализы крови

Показатели	Что оценивают
СРБ ультрачувствительный, СОЭ	Общий уровень воспаления: только локально в ЖКТ или уже системное хроническое воспаление
Общий анализ крови, ферритин, B12, фолиевая кислота (по желанию)	Дефицит железа и кофакторов. При длительном воспалении особенно страдает усвоение B12 и железа
Общий белок, альбумин	Усвоение белка — пул аминокислот в организме
АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой	Функция печени и желчевыводящих путей: воспаление, застой жёлчи
Амилаза, липаза	Чувствительные маркеры воспаления поджелудочной — при подостром состоянии, острых жалобах или регулярных панкреатических приступах. При плановом обследовании могут не назначить

4.5. Кал на панкреатическую эластазу

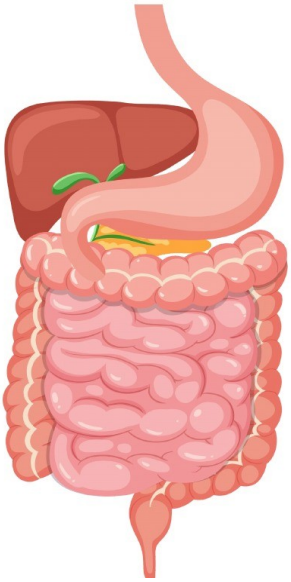
Показывает, насколько эффективно поджелудочная выделяет ферменты. При хроническом воспалении, особенно при хроническом панкреатите, её функция со временем снижается. Удобно сдать вместе с кальпротектином и скрытой кровью — «чтобы два раза не вставать».

4.6. Водородно-дыхательный тест

Оценивает **СИБР**, а также непереносимость лактозы, фруктозы и других сахаров. СИБР — разрастание патогенной микрофлоры в тонкой кишке, которая в норме стерильна; бактерии производят газ (водород, метан) → вздутие, боли, нарушения стула.

> **Важно:** сейчас СИБР часто ставят только по факту вздутия и сразу назначают антибиотики. Перед этим стоит проверить, действительно ли дело в СИБР. Если вздувает «на всё», особенно на ферментированное (квашеные овощи, кисломолочное, комбуча) и пробиотики, — имеет смысл сдать тест. Он доступен в частных лабораториях.

5. Цель программы «Формула здоровья ЖКТ»



- **снизить уровень воспаления** в ЖКТ;
- **профилактировать дальнейшее развитие** воспаления;
- **снизить риск обострений;**
- **поддержать пищеварительные функции** органов ЖКТ и улучшить всасывание питательных веществ — ведь признаки вялого типа есть даже при воспалении;
- **повысить качество жизни и энергию**, уменьшить жалобы, стабилизировать работу ЖКТ.

Всё это — **мягкими, бережными методами**: поддержать работу органов и не вызвать обострение.

Как мы будем работать: от простого к сложному

Программа длится **5 недель**. Стратегия разворачивается постепенно:

1. **Подготовка кишечника** мягкими сорбентами.
2. **Налаживание режима дня.**
3. **Регуляция нервной системы**, снижение хронического стресса.
4. **Напитки** с противовоспалительными травами.

5. **Коррекция питания**: убрать то, что мешает пищеварению и поддерживает воспаление.
6. **Полноценное меню из легкоусвояемых блюд** — противовоспалительное и закрывающее дефициты питательных веществ.
7. **Специи и травы** для устранения хронического воспаления и заживления слизистой.

> **Задание на первую неделю:** посмотрите другие уроки недели — там списки трав и специй, первые рецепты напитков и блюд. Проверьте, что из этого есть дома, и докупите недостающее. Не торопитесь — программа большая, но вы всё успеете.

Вопросы для самопроверки

1. Что происходит в ЖКТ при воспалительном типе пищеварения? Какие органы могут быть вовлечены?
2. Какие изменения микробиома возможны на фоне хронического воспаления?
3. Назовите типичные диагнозы при воспалительном типе пищеварения.
4. Какие жалобы характерны для хронического воспаления в ЖКТ? Сколько пунктов достаточно, чтобы его заподозрить?
5. Почему со временем к воспалительным признакам добавляются признаки вялого и чувствительного типа? Какие это признаки?
6. Какие риски несёт воспалительный тип пищеварения?
7. Что описывает каскад Корреа и почему важно работать с хроническим воспалением?
8. Кто должен назначать и оценивать анализы при воспалительном типе пищеварения?
9. Что показывает УЗИ органов брюшной полости и зачем нужно УЗИ с нагрузкой?
10. В каких случаях оправдана ФГДС и зачем при ней берут биопсию?
11. Чем анализ кала на кальпротектин удобнее колоноскопии?
12. Какие анализы крови помогают оценить общий уровень воспаления, дефициты и усвоение белка?
13. Что показывает кал на панкреатическую эластазу?
14. Что оценивает водородно-дыхательный тест и почему его стоит сдать перед лечением СИБР антибиотиками?
15. Какие цели у программы «Формула здоровья ЖКТ»?
16. Из каких шагов состоит стратегия работы на программе?